HELP_Organi_P11 — Groupe B — Lots 227 à 231 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 11 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

B-046 — Haute — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › fenêtre post-COVID-19 ; Partie 4 › DX.8 (EM/SFC et post-COVID-19) › divergence NICE/EUROMENE, traitements, surveillance

Contexte : Le cours suit NICE 2021 et EUROMENE 2021 ; la page de l'OFSP sur l'affection post-COVID-19 n'a pas pu être lue, et aucune recommandation suisse n'a été trouvée. Il n'existe aucun médicament autorisé.

Question : Quelles recommandations suisses existent sur l'affection post-COVID-19 et l'EM/SFC (OFSP, SSMIG, « Swiss Post-COVID Care », SSP pédiatrie ; titre, année, URL) ? Quelle définition et quelle durée retiennent-elles ? Une recommandation européenne plus récente que NICE 2021 et EUROMENE 2021 existe-t-elle ? Quels traitements symptomatiques et quel suivi recommande-t-on ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-042 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › épidémiologie ; Partie 1 › DX.1-DX.2 ; Partie 2 › DX.3-DX.5 ; Partie 4 › DX.8-DX.9 › tableaux de prévalence

Contexte : Le cours n'a trouvé aucune prévalence nationale suisse des troubles somatoformes, des épisodes dépressifs, des troubles anxieux, du SII, de l'EM/SFC ni de l'hypocondrie. Il cite des sous-groupes de l'ESS 2022 (Obsan) et des chiffres mondiaux ou européens.

Question : Quelles prévalences suisses publient l'Obsan, l'OFS (ESS 2022) ou des études suisses pour la dépression, les troubles anxieux, les troubles somatoformes ou de détresse corporelle, le SII, l'EM/SFC, l'affection post-COVID-19 et l'hypocondrie ? Donne la source, l'année, la population et l'URL. À défaut, donne la référence européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-047 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 1 › DX.1-DX.2 › cadre déontologique (certificats) ; Partie 3 › fenêtre « Communication et alliance thérapeutique » ; Partie 4 › DX.10 › source CP

Contexte : Le cours écrit que le code de déontologie de la FMH sur les certificats, les demandes d'examens et l'annonce du diagnostic n'a pas été relu. Il cite le CP (état au 1.10.2026).

Question : Que prévoit le code de déontologie de la FMH en vigueur (articles exacts, version, URL) sur les certificats médicaux, l'information du patient et les examens inutiles ? Que disent les directives FMH sur les certificats d'incapacité de travail ? Quelles sanctions prévoit le CP art. 318 pour un faux certificat médical ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-048 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 › fenêtres « diarrhée nocturne », « Diarrhée chronique », « diarrhée des acides biliaires » ; DX.5 (SII) › sous-types SII-C, SII mixte, SII non classé, fenêtre Bristol

Contexte : Le cours n'a trouvé ni le seuil de durée de la diarrhée chronique, ni les critères détaillés des sous-types Rome (mixte, non classé), ni la disponibilité en Suisse des dosages des acides biliaires.

Question : Selon Rome IV et Rome V (2026), quels critères de proportion des selles de Bristol définissent les sous-types SII-C, SII-D, SII-M et SII non classé ? Quelle durée définit la diarrhée

chronique selon la recommandation européenne la plus récente (≥ 4 semaines) ? Le SeHCAT et le dosage du C4 sérique sont-ils disponibles en Suisse ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-049 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › fenêtres « signe de Hoover » et « vidéo-EEG (crises fonctionnelles) » ; Partie 3 › DX.7 › tableau lactate

Contexte : Le cours cite 14 signes positifs validés (sensibilité 8 à 100 %, spécificité 92 à 100 %) sans les valeurs propres au signe de Hoover. Il n'a trouvé ni le seuil de positivité de la vidéo-EEG, ni la valeur du lactate après une crise.

Question : Quelles sont la sensibilité et la spécificité du signe de Hoover dans la parésie fonctionnelle ? Quels critères de l'ILAE (2013 ou mise à jour) classent une crise fonctionnelle comme documentée ? Quelle valeur et quel délai de la prolactine et du lactate distinguent une crise épileptique d'une crise fonctionnelle ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-050 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 2 › fenêtre « Ce qui la distingue » ; Partie 1 › fenêtre « bilan algométrique » ; Partie 3 › DX.6 (fibromyalgie) › rhumatisme inflammatoire, algométrie

Contexte : Le cours n'a trouvé ni valeur normale ni seuil de douleur à la pression en algométrie, ni critère chiffré qui distingue la fibromyalgie d'un rhumatisme inflammatoire.

Question : Quels critères diagnostiques de la fibromyalgie recommandent l'EULAR et toute recommandation suisse (SSR) dans leurs éditions les plus récentes (ACR 2016 : WPI et SSS) ? Quel bilan biologique minimal écarte un rhumatisme inflammatoire ? Quelles valeurs normales du seuil de douleur à la pression a-t-on publiées ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-051 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 2 › ligne DX.9 ; Partie 4 › DX.9 (hypocondrie) › gold standard et traitements pharmacologiques

Contexte : Le cours n'a trouvé aucun questionnaire validé de l'anxiété de maladie ni de preuve d'efficacité des ISRS dans l'hypocondrie.

Question : Quels questionnaires validés en français ou en allemand mesurent l'anxiété de maladie (Whiteley Index, SHAI), et avec quels seuils ? Quelle efficacité des ISRS montrent les méta-analyses récentes dans l'hypocondrie, et quelle recommandation européenne la plus récente traite cette affection ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-052 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.10 (trouble factice, simulation) › tableau des examens d'orientation et traitement

Contexte : Le cours n'a trouvé aucune valeur ni aucun seuil pour les dosages de médicaments, les tests de validation des symptômes et la preuve objective d'une falsification. Il n'a trouvé aucun traitement fondé sur des preuves.

Question : Quels tests de validation des symptômes et de l'effort sont recommandés dans les expertises suisses (SIM, SSPP/SGPP ; guide d'expertise psychiatrique) ? Avec quels seuils ? Quelle prise en charge du trouble factice recommandent les revues ou recommandations européennes les plus récentes ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-053 — Moyenne — LOT 230 · SSP O7.8

Emplacement : LOT_230_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 (troubles anxieux) › examens complémentaires et A- But

Contexte : Le cours écrit qu'on passe à des examens complémentaires devant une suspicion organique, sans les préciser, et qu'aucun score GAD-7 cible n'est chiffré.

Question : Quel bilan organique minimal recommande la recommandation suisse SSAD 2024 (ou européenne) avant de retenir un trouble panique ou un TAG (ECG, TSH, glycémie, toxiques) ? Quels seuils du GAD-7 définissent le dépistage, la réponse et la rémission ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-055 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 2 › références HAP/PAV ; Partie 1 › DX.2 (pneumonie nosocomiale) › fenêtres « mesures du bundle nvHAP », « recommandations internationales HAP/PAV de 2017 », piège des spécialités suisses, pronostic

Contexte : Le cours suit la directive KSSG et n'a lu qu'en résumé les recommandations ERS/ESICM/ESCMID/ALAT de 2017 sur la HAP et la PAV. Il n'a pas vérifié les spécialités suisses de la flucloxacilline, du ceftazidime, de la tobramycine, de la lévofloxacine, de la moxifloxacine, de l'azithromycine, du zanamivir et de la clindamycine.

Question : Quelle est la recommandation européenne la plus récente sur la HAP et la PAV (ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 ou mise à jour ; ESCMID 2024-2026) ? Quelle antibiothérapie empirique (molécules, doses, durée de 7 jours) recommande-t-elle selon le risque de BMR et de mortalité ? Existe-t-il une recommandation suisse (SSI, Swissnoso) ? Liste les spécialités suisses (IP) des huit molécules citées, avec leurs doses et leurs adaptations rénales. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, auteur, année, URL) ; compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-057 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.1 (ISO) › fenêtres « imagerie » et « chirurgie de la prothèse infectée (KSSG) » ; C- Surveillance (clinique, biologique) ; D- Pronostic

Contexte : Le cours cite les creux de vancomycine (10-20 mg/l selon l'IP, 15-20 mg/l selon le KSSG) et la surveillance sous rifampicine. Il n'a trouvé ni le calendrier des contrôles, ni l'imagerie de l'ISO, ni le traitement chirurgical hors prothèse, ni les critères de guérison.

Question : Quelle cible de vancomycine faut-il viser en 2026 : creux ou ASC/CMI 400-600 (consensus ASHP/IDSA/SIDP 2020, recommandation suisse ou européenne) ? À quelle fréquence la contrôle-t-on ? Selon l'IP suisse de la rifampicine, quelle surveillance faut-il ? Quelle prise en charge chirurgicale et antibiotique (durée) recommande-t-on pour l'ISO profonde et d'organe hors prothèse (SSI, ESCMID, WSES) ? Quelle imagerie et quels critères de guérison faut-il retenir ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-058 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 (bactériémie sur cathéter) › B- Moyens (verrou antibiotique) et 9.d examens de 2e intention

Contexte : Le cours écrit que les doses du verrou antibiotique (vancomycine ou ciprofloxacine) pour un cathéter de longue durée et l'imagerie des complications ne figurent pas dans les sources consultées.

Question : Quelles concentrations et quelles durées du verrou antibiotique (vancomycine, céfazoline, gentamicine, ciprofloxacine, avec ou sans héparine) recommandent la directive KSSG, les HUG ou l'ESCMID/IDSA dans leurs versions les plus récentes ? Quand faut-il une échocardiographie (ETT ou ETO) ou un écho-doppler veineux dans une bactériémie sur cathéter à S. aureus ou à Candida ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-059 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtre « raisonnement : urine de sonde » ; Bloc 2 › ligne CAUTI ; Partie 2 › DX.4 (CAUTI) › 9.d, tableau des traitements (Pipéracilline/Tazobactam Sandoz®, Meronem®), recherche 2026

Contexte : Le cours oppose le seuil de surveillance (10^5 UFC/ml, Swissnoso/ECDC) au seuil clinique du KSSG (10^3 UFC/ml). Il n'a pas pu lire les lignes directrices EAU 2025/2026. Il n'a pas trouvé les doses adultes de Pipéracilline/Tazobactam Sandoz® et de Meronem® dans la CAUTI.

Question : Que recommandent les lignes directrices EAU les plus récentes (2025 ou 2026) sur le diagnostic de la CAUTI (seuil d'UFC, changement de sonde avant la culture), sur l'antibiothérapie (molécules, durée de 7 ou 10 à 14 jours) et sur la prévention ? Donne, selon les IP suisses, les doses adultes de pipéracilline/tazobactam et de méropénem dans l'infection urinaire compliquée, avec leurs adaptations rénales. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, auteur, année, URL) ; compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-060 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 2 › fenêtre « recherche 2026 » ; Partie 2 › DX.5 (ICD) › fenêtres « Leucocytose », « Endoscopie ou histologie », « remboursement de la fidaxomicine », tableau Flagyl®, recherche 2026

Contexte : Le cours suit la directive suisse sur l'ICD (versions abrégée et étendue). Il note un seuil de leucocytose ambigu (« > 15 000 cellules/ml »), des limitations LS de la fidaxomicine non vérifiées et l'absence d'indication formelle de l'endoscopie. Il cite l'essai suisse de transplantation de microbiote fécal NCT05266807.

Question : Quel est le seuil exact de leucocytose (> 15 G/l) de l'ICD sévère selon l'ESCMID 2021 (ou mise à jour) et la directive suisse citée ? Quelle limitation de la LS s'applique à Dificlir® (fidaxomicine) au 22.10.2026 ? Quand l'endoscopie est-elle indiquée ? Quel est le statut réglementaire suisse de la transplantation de microbiote fécal (Swissmedic : produit transplantable

ou médicament ; autorisations) ? Quels traitements recommande-t-on en 2026 pour le 1er épisode et les récidives (vancomycine, fidaxomicine, bezlotoxumab), avec les doses de l'IP suisse ? Rappelle la dose de métronidazole chez l'enfant. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, auteur, année, URL) ; compare la version la plus récente à celle citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-062 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 2 › ligne DX.8 ; Partie 4 › DX.8 (candidémie) › tableau « répartition des espèces et sensibilité », bêta-D-glucane, hémocultures, 2e intention, adaptation rénale, fenêtre « rézafungine »

Contexte : Le cours cite la répartition au CHUV (C. albicans 53 %, C. glabrata 27 %) et le traitement par anidulafungine (200 mg puis 100 mg/j). Il n'a trouvé ni la sensibilité de C. tropicalis et de C. krusei, ni le seuil du bêta-D-glucane, ni la recommandation d'échocardiographie et de fond d'œil, ni le statut suisse de la rézafungine (Rezzayo®).

Question : Selon la recommandation ECMM/ISHAM/ASM 2025 et toute recommandation suisse (SSI, FUNGINOS), quand faut-il faire une échocardiographie, un fond d'œil et des hémocultures de contrôle dans une candidémie ? Quelle durée de traitement faut-il ? Quel seuil de bêta-D-glucane (pg/ml) retient-on ? Quelles sensibilités aux azolés et aux échinocandines rapporte FUNGINOS ou ANRESIS pour C. tropicalis et C. krusei ? Rezzayo® (rézafungine) est-il autorisé par Swissmedic au 22.10.2026 ? Donne les adaptations rénales des antifongiques cités selon les IP suisses.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-064 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 3 › DX.6 › simulateurs non viraux ; Partie 4 › DX.9 › fenêtres « fièvre médicamenteuse : fréquence », « références par entité » (contamination d'un produit sanguin), tableau plaquettes (TIH), « cadre légal : hémovigilance »

Contexte : Le cours écrit qu'aucun critère formel de la fièvre médicamenteuse n'a été trouvé. Il ne donne pas la référence pour la contamination bactérienne d'un produit sanguin. Il cite la baisse de 30 à 50 % des plaquettes entre J5 et J21 sous héparine (IP de Clexane®).

Question : Quelle conduite recommande l'hémovigilance de Swissmedic (et Transfusion CRS Suisse) face à une fièvre pendant une transfusion : arrêt, cultures du patient et de la poche, délai de déclaration selon l'OMéd ? Quels critères diagnostiques de la fièvre médicamenteuse retient une source européenne récente ? Quel score (4T) et quelle conduite pour la thrombopénie induite par l'héparine recommande la recommandation suisse ou européenne la plus récente (anticoagulant de relais disponible en Suisse, dose) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-066 — Haute — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 (virus respiratoires) › 9.c Alternatives et critères de levée de l'isolement

Contexte : Le cours suit Swissnoso : dépistage immédiat adapté à l'âge et isolement tant que durent les symptômes chez l'enfant, panel élargi chez l'immunodéprimé sévère. La grossesse et les autres situations n'ont pas été trouvées.

Question : Quelles sont les recommandations Swissnoso les plus récentes (2025-2026) pour l'isolement et sa levée en cas de COVID-19, de grippe et de VRS nosocomiaux chez l'adulte, l'enfant, l'immunodéprimé et la femme enceinte ? Quelles indications de traitement antiviral donnent les IP suisses (Paxlovid®, oseltamivir) pendant la grossesse et en insuffisance rénale ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-054 — Moyenne — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Bloc 1 › fenêtres « objectifs NOSO » et « justification du rang » ; Partie 1 › DX.1-DX.2 › épidémiologie ; Partie 2 › DX.3 › pronostic ; Partie 3 › DX.6-DX.7 › épidémiologie et pronostic

Contexte : Le cours cite les anciennes estimations de Swissnoso (environ 70 000 cas et 2 000 décès par an, jusqu'à 50 % évitables) et la CH-PPS. Il n'a trouvé ni la mortalité attribuable actuelle, ni la part suisse de l'ICD et des virus respiratoires, ni la répartition des ISO par profondeur, ni la mortalité attribuable des bactériémies sur cathéter et des BMR en Suisse.

Question : Quelles sont les données suisses les plus récentes (CH-PPS 2024 ou 2025 de Swissnoso, ANQ, stratégie NOSO de l'OFSP, ANRESIS) sur : le nombre de cas et de décès attribuables aux IAS, la part de l'ICD et des virus respiratoires, la répartition des ISO superficielles, profondes et d'organe, la part de S. aureus, la mortalité attribuable des bactériémies sur cathéter et les taux de MRSA, d'ERV, d'E-BLSE et d'EPC en 2025 ? Donne l'année, la méthode et l'URL.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

B-056 — Moyenne — LOT 231 · SSP O7.9

Emplacement : LOT_231_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_231_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Bloc 2 › tableau « grossesse, enfant, insuffisance rénale, contraste » ; Partie 1 › DX.1-DX.2 › 9.c Alternatives

Contexte : Le cours écrit que l'imagerie de l'ISO et de la pneumonie pendant la grossesse, chez l'enfant et en insuffisance rénale n'a pas été trouvée. Il cite les restrictions de la ciprofloxacine, de la céfazoline et de Bactroban Nasal®.

Question : Quelle imagerie recommande-t-on pour une pneumonie nosocomiale ou une infection du site chirurgical pendant la grossesse et chez l'enfant (radiographie, échographie pulmonaire, scanner, IRM ; recommandation européenne ou suisse la plus récente) ? Quels antibiotiques de ces infections sont permis pendant la grossesse selon les IP suisses ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P11 — 19 questions : B-046, B-042, B-047, B-048, B-049, B-050, B-051, B-052, B-053, B-055, B-057, B-058, B-059, B-060, B-062, B-064, B-066, B-054, B-056